INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Zeitschrift für *Sinnzentrierte* Psychologie

Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026 · Deutsche Ausgabe

Sinn, Werte und existenzielle Herausforderungen in der psychotherapeutischen Praxis

Logotherapie · Existenzpsychologie · Psychotherapieforschung

S. 18–33 · Open Access

Inhalt

Heft 2/2026 · Schwerpunkt: Sinn, Werte und existenzielle Herausforderungen in der psychotherapeutischen Praxis · Seitenzahlen der englischen Originalfassung

EDITORIAL

Werte, Begegnung und die Grenzen des Machbaren 18

Zum Schwerpunkt des zweiten Heftes

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer und Samuel R. Ashford

THEORETISCHER BEITRAG

Werte in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie und Frankls Wertkategorien 20

Konvergenzen und Differenzen zweier Wertkonzeptionen

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford und Sora Pazer

ÜBERSICHTSARBEIT

Meaning-Centered Psychotherapy in der Palliativversorgung 23

Konzeption, Evidenzlage und Fragen der Übertragbarkeit

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe

PRAXIS UND LEHRE

Logotherapeutisch orientierte Beratung bei Burnout und Sinnkrisen 27

Grundzüge, Vorgehen und Grenzen – mit einer konstruierten Lehrvignette

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer und Samuel R. Ashford

REZENSION

Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager 31

Viktor E. Frankls „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ bzw. „Man’s Search for Meaning“ – eine Relektüre aus heutiger Sicht

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe und Sora Pazer

Herausgeber
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Erscheinungsweise
halbjährlich, im April und Oktober, dazu Themenhefte

Begutachtung
Redaktionelle Prüfung und doppelt verblindetes Gutachterverfahren

Lizenz und Einsatz von KI
Alle Beiträge erscheinen im offenen Zugang unter CC BY 4.0. Sie wurden mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft. Originalsprache ist Englisch; die deutsche Ausgabe ist eine Übersetzung.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE
Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026
S. 18–19 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

EDITORIAL

Werte, Begegnung und die Grenzen des Machbaren

Zum Schwerpunkt des zweiten Heftes

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer und Samuel R. Ashford
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Das zweite Heft des ersten Jahrgangs der Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie wendet sich von den forschungsmethodischen Grundfragen des ersten Heftes stärker der therapeutischen und beraterischen Praxis zu. Unter dem Schwerpunkt „Sinn, Werte und existenzielle Herausforderungen in der psychotherapeutischen Praxis“ versammelt es Beiträge, die zentrale Konzepte der Logotherapie mit gegenwärtigen Verfahren und Versorgungskontexten ins Gespräch bringen. Ein theoretischer Beitrag vergleicht das Wertekonzept der Akzeptanz- und Commitment-Therapie mit Viktor E. Frankls Wertkategorien. Eine Übersichtsarbeit beschreibt die Meaning-Centered Psychotherapy in der Palliativversorgung und ordnet ihre Evidenzbasis ein. Ein Beitrag aus Praxis und Lehre entwickelt Grundzüge logotherapeutisch orientierter Beratung bei Burnout und Sinnkrisen. Eine Rezension würdigt Frankls Bericht „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ aus heutiger Perspektive. Das Editorial skizziert den gemeinsamen Bezugspunkt der Beiträge: die Frage, wie Psychotherapie mit dem umgehen kann, was sich nicht ändern lässt, und welche Rolle Werte und Sinn dabei spielen. Zugleich wird an die redaktionellen Grundsätze erinnert, insbesondere an die klare Kennzeichnung didaktischer Fallvignetten als konstruierte Lehrbeispiele.

Schlüsselwörter: Werte · Logotherapie · Psychotherapeutische Praxis · Palliativversorgung · Editorial

ABSTRACT

The second issue of the first volume of the Journal of Meaning-Centered Psychology shifts its focus from the methodological questions of the first issue toward therapeutic and counseling practice. Under the theme “Meaning, values, and existential challenges in psychotherapeutic practice,” it brings together papers that relate central concepts of logotherapy to contemporary treatments and settings of care. A theoretical paper compares the concept of values in acceptance and commitment therapy with Viktor E. Frankl's categories of values. A review describes meaning-centered psychotherapy in palliative care and appraises its evidence base. A contribution on practice and teaching outlines principles of logotherapeutically informed counseling for burnout and crises of meaning. A book review reassesses Frankl's account “Man's Search for Meaning” from a contemporary perspective. The editorial sketches the common point of reference of these papers: the question of how psychotherapy can deal with what cannot be changed, and which role values and meaning play in this respect. It also recalls the journal's editorial principles, in particular the clear labeling of didactic case vignettes as constructed teaching examples.

Keywords: values · logotherapy · psychotherapeutic practice · palliative care · editorial

Vom Forschungsstand zur Praxis

Das erste Heft dieser Zeitschrift war der Frage gewidmet, wie sich die Logotherapie im Kontext der gegenwärtigen Psychotherapieforschung verorten lässt. Das vorliegende zweite Heft wendet sich stärker der therapeutischen und beraterischen Praxis zu. Sein Schwerpunkt lautet „Sinn, Werte und existenzielle Herausforderungen in der psychotherapeutischen Praxis“. Der Perspektivwechsel bedeutet keine Abkehr vom Anspruch wissenschaftlicher Sorgfalt; er reagiert vielmehr auf die Beobachtung, dass gerade in der Praxis begriffliche Unschärfen besonders folgenreich sein können.

Ein verbindendes Motiv der Beiträge ist die Frage, wie Psychotherapie mit dem umgehen kann, was sich nicht ändern lässt. Frankl (1946) hat neben schöpferischen Werten und Erlebniswerten die Einstellungswerte beschrieben, die sich in der Haltung eines Menschen gegenüber unabänderlichem Leid verwirklichen. Yalom (1980) hat Tod, Freiheit,

Isolation und Sinnlosigkeit als existenzielle Grundgegebenheiten benannt, mit denen sich jede Psychotherapie früher oder später auseinandersetzen muss.

Für die psychotherapeutische Praxis hat diese Frage unmittelbare Bedeutung. Viele Behandlungsansätze sind darauf ausgerichtet, Veränderung herbeizuführen: Symptome sollen abnehmen, dysfunktionale Muster sich auflösen, Fähigkeiten wachsen. Doch nicht alles, was Menschen belastet, lässt sich verändern. Chronische und lebensbegrenzende Erkrankungen, Verluste, irreversible Lebensentscheidungen oder strukturelle Bedingungen der Arbeitswelt setzen dem therapeutisch Machbaren Grenzen. Gerade an diesen Grenzen gewinnt die Frage nach Sinn und Werten an Gewicht.

Die Beiträge dieses Heftes

Der Arbeitsbereich Kognitive Verhaltenstherapie und kontextuelle Verfahren vergleicht das Wertekonzept der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (Hayes et al., 2012) mit Frankls Wertkategorien und fragt, wo es sich um echte Konvergenzen und wo um bloße Familienähnlichkeiten handelt. Der Arbeitsbereich Psychoonkologie und Palliativpsychologie legt eine Übersichtsarbeit zur Meaning-Centered Psychotherapy vor, die zu den am sorgfältigsten untersuchten sinnzentrierten Interventionen gehört (Breitbart et al., 2015).

Der Beitrag aus Praxis und Lehre des Arbeitsbereichs Beratungspsychologie entwickelt Grundzüge logotherapeutisch orientierter Beratung bei Burnout und Sinnkrisen. Er arbeitet mit einer ausdrücklich als konstruiert gekennzeichneten Lehrvignette und grenzt Beratung sorgfältig von der Behandlung psychischer Störungen ab. Den Abschluss bildet eine Rezension von Frankls Bericht „… trotzdem Ja zum Leben sagen“, die nach der bleibenden Bedeutung, aber auch nach den Grenzen dieses vielgelesenen Buches fragt.

Die Beiträge zeigen in unterschiedlicher Weise, dass die Auseinandersetzung mit diesen Grenzen keine Resignation bedeuten muss. Sie verlangt allerdings eine Haltung, die weder vorschnell Trost spendet noch Leiden zu einem Mittel der Sinnfindung verklärt. Frankl selbst hat betont, dass vermeidbares Leid zu beseitigen sei und erst das unvermeidbare Leid eine Gelegenheit zur Verwirklichung von Einstellungswerten biete (Frankl, 1946).

Ausblick

Mit diesem Heft schließt der erste Jahrgang der Zeitschrift. Die Redaktion dankt den beteiligten Arbeitsbereichen für ihre Beiträge und für die Bereitschaft, sich auf die Integritätsgrundsätze der Zeitschrift einzulassen: zurückhaltende Wiedergabe empirischer Befunde, transparente Kennzeichnung theoretischer Setzungen und konstruierter Fallbeispiele sowie konsequente Orientierung an überprüfbaren Quellen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Diskussion im kommenden Jahrgang.

Literatur

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Whitcombe, E. M., Pazer, S., & Ashford, S. R. (2026). Values, Encounter, and the Limits of What Can Be Done: On the Focus of the Second Issue. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 18–19.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026
S. 20–22 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

THEORETISCHER BEITRAG

Werte in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie und Frankls Wertkategorien

Konvergenzen und Differenzen zweier Wertkonzeptionen

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford und Sora Pazer
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Werte nehmen sowohl in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) als auch in der Logotherapie eine zentrale Stellung ein. In der ACT gelten Werte als frei gewählte, verbal konstruierte Qualitäten fortlaufenden Handelns, die engagiertes Verhalten ausrichten und der psychologischen Flexibilität eine Richtung geben. Viktor E. Frankl unterschied dagegen schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungswerte, die nach seinem Verständnis nicht erfunden, sondern in der jeweiligen Situation gefunden werden. Der vorliegende theoretische Beitrag vergleicht beide Konzeptionen systematisch. Herausgearbeitet werden Konvergenzen, etwa die Unterscheidung zwischen Werten und Zielen, die Betonung von Handlung und Engagement, die Bedeutung von Werten im Umgang mit unvermeidlichem Leid sowie die Funktion von Werten als Gegengewicht zu einer ausschließlich symptomorientierten Therapie. Zugleich werden grundlegende Differenzen beleuchtet, die sich aus unterschiedlichen philosophischen Hintergründen ergeben: dem funktionalen Kontextualismus der ACT einerseits und der phänomenologisch-personalistischen Anthropologie Frankls andererseits. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, ob Werte gewählt oder entdeckt werden, sowie dem Status der Einstellungswerte. Der Beitrag schließt mit Überlegungen dazu, wie beide Traditionen voneinander lernen können, ohne ihre jeweiligen Prämissen zu verwischen.

Schlüsselwörter: Akzeptanz- und Commitment-Therapie · Werte · Logotherapie · Einstellungswerte · Psychologische Flexibilität

ABSTRACT

Values occupy a central position in both acceptance and commitment therapy (ACT) and logotherapy. In ACT, values are understood as freely chosen, verbally constructed qualities of ongoing action that guide committed behavior and give direction to psychological flexibility. Viktor E. Frankl, in contrast, distinguished creative, experiential, and attitudinal values, which, in his view, are not invented but discovered in the respective situation. This theoretical paper systematically compares the two conceptions. It identifies convergences, such as the distinction between values and goals, the emphasis on action and engagement, the significance of values in dealing with unavoidable suffering, and the function of values as a counterweight to an exclusively symptom-oriented therapy. At the same time, it highlights fundamental differences that arise from distinct philosophical backgrounds: the functional contextualism of ACT on the one hand and Frankl's phenomenological and personalist anthropology on the other. Particular attention is paid to the question of whether values are chosen or discovered and to the status of attitudinal values. The paper concludes with reflections on how both traditions can learn from each other without blurring their respective premises.

Keywords: acceptance and commitment therapy · values · logotherapy · attitudinal values · psychological flexibility

1 Einleitung

In der Psychotherapie der vergangenen Jahrzehnte hat der Begriff der Werte eine bemerkenswerte Renaissance erfahren. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT), die Werte als einen ihrer sechs Kernprozesse ausweist (Hayes et al., 1999, 2012). Für Leserinnen und Leser, die mit der Logotherapie vertraut sind, ist diese Entwicklung von besonderem Interesse, denn Frankl hatte bereits Jahrzehnte zuvor eine Wertlehre entwickelt, die im Zentrum seines psychotherapeutischen Ansatzes steht (Frankl, 1946).

Die naheliegende Vermutung, es handle sich um zwei Varianten derselben Grundidee, greift jedoch zu

kurz. Beide Traditionen sind in unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen und anthropologischen Kontexten entstanden, und dieselben Begriffe tragen in ihnen teils verschiedene Bedeutungen. Der vorliegende Beitrag vergleicht beide Konzeptionen, um Gemeinsamkeiten präzise zu benennen und Unterschiede nicht vorschnell einzuebnen.

Der Vergleich gliedert sich in vier Schritte. Zunächst wird das Wertekonzept der ACT in seinen theoretischen Zusammenhang gestellt, anschließend Frankls Wertlehre skizziert. Darauf aufbauend werden Konvergenzen und Differenzen herausgearbeitet. Abschließend wird erörtert, welche Folgerungen sich für Praxis, Diagnostik und Forschung ergeben. Der Beitrag beschränkt sich dabei auf die konzeptuelle Ebene und trifft keine Aussagen über die vergleichende Wirksamkeit beider Ansätze.

2 Werte in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie

Die ACT versteht sich als Anwendung des funktionalen Kontextualismus und der Bezugsrahmentheorie, eines verhaltensanalytischen Ansatzes zur Erklärung menschlicher Sprache und Kognition (Hayes et al., 2001). Psychisches Leiden entsteht nach diesem Verständnis wesentlich durch psychologische Inflexibilität, also durch die Dominanz starrer verbaler Regeln, erlebnisvermeidender Strategien und eine Verengung des Verhaltensrepertoires (Hayes et al., 2006). Psychologische Flexibilität gilt umgekehrt als grundlegender Aspekt psychischer Gesundheit (Kashdan & Rottenberg, 2010).

Werte werden in der ACT als frei gewählte, verbal konstruierte Konsequenzen fortlaufender, sich entwickelnder Handlungsmuster beschrieben, die als Verstärker wirken und dem Handeln Richtung verleihen (Hayes et al., 2012). Wesentlich ist die Unterscheidung von Werten und Zielen: Ziele können erreicht und abgeschlossen werden, Werte dagegen gleichen einer Himmelsrichtung, an der man sich orientiert, ohne je anzukommen. Werte sollen zudem nicht aus Pflicht, sozialem Druck oder dem Wunsch nach Schmerzvermeidung abgeleitet, sondern als persönlich bedeutsam erlebt werden. Für die Erfassung wertorientierten Handelns wurden eigene Instrumente entwickelt, etwa der Valued Living Questionnaire (Wilson et al., 2010).

In der therapeutischen Arbeit werden Werte in der ACT häufig über erlebnisorientierte Übungen erschlossen, etwa durch die Vorstellung der eigenen Trauerfeier oder durch die Frage, wofür man im Leben stehen möchte (Hayes et al., 1999). Wertklärung ist dabei kein einmaliger Akt, sondern ein fortlaufender Prozess, der eng mit engagiertem Handeln verknüpft ist. Zugleich wird darauf geachtet, Werte nicht als neue starre Regeln zu etablieren, die ihrerseits zu Inflexibilität führen könnten.

3 Frankls Wertkategorien

Frankl unterschied drei Hauptwege, auf denen Menschen Sinn verwirklichen können (Frankl, 1946, 1955). Schöpferische Werte verwirklichen sich in dem, was ein Mensch der Welt gibt, etwa durch Arbeit oder Gestaltung. Erlebniswerte verwirklichen sich in dem, was ein Mensch von der Welt empfängt, etwa in der Begegnung mit Natur, Kunst oder einem anderen Menschen. Einstellungswerte schließlich verwirklichen sich in der Haltung, die ein Mensch gegenüber einem unabänderlichen Schicksal, insbesondere gegenüber unvermeidbarem Leid, einnimmt.

Für Frankl werden Sinn und Werte nicht erfunden, sondern gefunden. Sinn ist nach seinem Verständnis jeweils situationsbezogen und richtet sich als Anruf an die einzelne Person, die darauf in Verantwortung antwortet (Frankl, 1969). Das Gewissen fungiert dabei als „Sinn-Organ“, das den einmaligen Sinn einer Situation erspüren kann. Diese Konzeption ist eingebettet in eine Anthropologie, die eine geistige Dimension des Menschen annimmt und Selbsttranszendenz – die Ausrichtung auf etwas oder jemanden jenseits der eigenen Person – als Kennzeichen menschlicher Existenz betrachtet.

Die Wertkategorien sind bei Frankl nicht im Sinne einer starren Hierarchie zu verstehen; gleichwohl hat er den Einstellungswerten eine besondere Würde zugesprochen, weil sie auch dort noch verwirklicht werden können, wo schöpferische und erlebnisbezogene Möglichkeiten erschöpft sind. Darin liegt die Pointe seiner These von der unbedingten Sinnhaftigkeit des Lebens: Solange ein Mensch lebt, bleibt ihm zumindest die Möglichkeit, zu seinem Schicksal Stellung zu nehmen (Frankl, 1946).

4 Konvergenzen

Trotz unterschiedlicher Herkunft lassen sich mehrere Konvergenzen benennen. Erstens betonen beide Ansätze die Unterscheidung zwischen einer übergreifenden Richtung und konkreten Zielen. Frankls Rede vom Sinn als Aufgabe, die sich in jeder Situation neu stellt, und die ACT-Metapher der Himmelsrichtung verweisen gleichermaßen darauf, dass Werte nicht abgehakt werden können. Zweitens legen beide Traditionen den Schwerpunkt auf

Handeln und Engagement statt auf bloße Einsicht. Drittens sehen beide in Werten ein Gegengewicht zu einer Therapie, die sich ausschließlich an der Reduktion von Symptomen orientiert.

Am auffälligsten ist die Nähe im Umgang mit unvermeidlichem Leid. Die ACT lädt dazu ein, schmerzhafte innere Erfahrungen nicht zu bekämpfen, sondern sie im Dienst wertgeleiteten Handelns anzunehmen. Frankls Einstellungswerte zielen auf eine verwandte Haltung: Wo eine Situation nicht geändert werden kann, bleibt die Freiheit, zu ihr Stellung zu nehmen. In beiden Fällen wird die Bewältigung von Leid nicht als dessen Beseitigung, sondern als Veränderung der Beziehung zu ihm verstanden.

5 Differenzen

Die grundlegendste Differenz betrifft den Status von Werten. In der ACT sind Werte gewählt; ihre Bedeutung ergibt sich aus ihrer Funktion für das Handeln einer Person, und der funktionale Kontextualismus verzichtet bewusst auf ontologische Aussagen darüber, ob es Werte unabhängig vom Menschen gibt (Hayes, 2004). Für Frankl dagegen sind Werte und Sinn nicht beliebig wählbar, sondern haben einen Aufforderungscharakter, der dem Menschen von außen entgegentritt. Diese Differenz ist nicht bloß terminologisch: Sie hat Folgen für die Frage, ob eine Therapeutin oder ein Therapeut Werte eines Klienten in Frage stellen darf, und für die Bedeutung von Verantwortung und Gewissen.

Eine zweite Differenz betrifft die Einstellungswerte. In der ACT ist Akzeptanz ein Prozess, der wertgeleitetes Handeln ermöglicht, aber selbst kein Wert. Bei Frankl hingegen kann die Haltung gegenüber dem Leid selbst sinnvoll sein – auch dann, wenn keine weiteren Handlungsmöglichkeiten bestehen. Diese Position erhält besonderes Gewicht in Situationen, in denen der Handlungsspielraum stark eingeschränkt ist, etwa bei schwerer Krankheit am Lebensende.

Eine dritte Differenz betrifft die Rolle der Selbsttranszendenz. Die ACT kennt mit dem Selbst-als-Kontext eine Perspektive, die über die Identifikation mit Selbstkonzepten hinausführt. Frankls Selbsttranszendenz meint jedoch etwas anderes: die Hinwendung zu einem Sinn oder einem anderen Menschen jenseits des eigenen Erlebens. Auch die Existenzanalyse hat die personale Stellungnahme als eigenständige Dimension betont (Längle, 2013).

Eine vierte Differenz betrifft das Verhältnis von Sprache und Sinn. In der ACT wird Sprache als zweischneidig betrachtet: Die Fähigkeit, Bezugsrahmen zu bilden, ermöglicht Werte und Zukunftsorientierung, ist aber zugleich Quelle von Grübeln, Selbstbewertung und Erlebnisvermeidung (Hayes et al., 2001). Frankl hingegen betrachtet die geistige Dimension nicht primär unter dem Aspekt ihrer Risiken, sondern als Quelle von Freiheit und Verantwortung. Die Skepsis der ACT gegenüber der Dominanz verbaler Regeln findet in der Logotherapie kein unmittelbares Gegenstück, wenngleich Frankls Kritik an der Hyperreflexion in eine verwandte Richtung weist.

6 Schlussfolgerungen

Der Vergleich zeigt, dass ACT und Logotherapie in ihrer praktischen Ausrichtung erstaunlich nahe beieinanderliegen, in ihren philosophischen Begründungen jedoch deutlich divergieren. Für die Praxis kann dies bereichernd sein: Die ACT bietet eine Vielzahl erprobter Übungen zur Klärung von Werten und zur Förderung psychologischer Flexibilität; die Logotherapie bietet eine differenzierte Sprache für den Umgang mit unabänderlichem Leid und für die Frage, worauf sich ein Mensch jenseits seiner selbst ausrichtet. Für die Forschung ergibt sich die Aufgabe, die Unterschiede in den Wertkonzeptionen so zu operationalisieren, dass ihre jeweiligen Beiträge zur Veränderung empirisch unterscheidbar werden. Eine eklektische Vermischung ohne Reflexion der Prämissen wäre dagegen weder der einen noch der anderen Tradition dienlich.

Für die Messung ergeben sich daraus unterschiedliche Anforderungen. Instrumente aus der ACT-Tradition erfassen typischerweise, wie wichtig einer Person bestimmte Lebensbereiche sind und wie konsistent sie im Einklang mit diesen handelt (Wilson et al., 2010). Logotherapeutische Konzepte wie die Verwirklichung von Einstellungswerten lassen sich mit solchen Instrumenten nur unzureichend abbilden, da sie gerade auch Situationen betreffen, in denen wertkonsistentes Handeln im üblichen Sinn kaum möglich ist. Hier besteht Entwicklungsbedarf für die Diagnostik.

Literatur

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1955). The doctor and the soul: An introduction to logotherapy. Knopf.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35(4), 639–665.

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (Eds.). (2001). Relational frame theory: A post-Skinnerian account of human language and cognition. Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865–878.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Wilson, K. G., Sandoz, E. K., Kitchens, J., & Roberts, M. (2010). The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. The Psychological Record, 60(2), 249–272.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Values in Acceptance and Commitment Therapy and Frankl's Categories of Values: Convergences and Differences Between Two Conceptions of Values. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 20–22.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026
S. 23–26 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

ÜBERSICHTSARBEIT

Meaning-Centered Psychotherapy in der Palliativversorgung

Konzeption, Evidenzlage und Fragen der Übertragbarkeit

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Menschen mit fortgeschrittenen, nicht heilbaren Erkrankungen sind neben körperlichen Beschwerden häufig mit existenziellen Belastungen konfrontiert, etwa mit Hoffnungslosigkeit, dem Erleben von Sinnverlust oder dem Wunsch nach einem beschleunigten Tod. Die von William Breitbart und Kolleginnen und Kollegen entwickelte Meaning-Centered Psychotherapy (MCP) ist eine manualisierte Intervention, die explizit an Viktor E. Frankls Logotherapie anknüpft und Patientinnen und Patienten darin unterstützen soll, auch angesichts begrenzter Lebenszeit Sinn zu erleben. Der vorliegende narrative Review beschreibt zunächst die theoretischen Grundlagen und den Aufbau der Intervention in ihrer Gruppen- und Einzelform. Anschließend wird die Evidenzlage aus randomisiert-kontrollierten Studien zusammengefasst, die insgesamt auf günstige Effekte hinsichtlich spirituellen Wohlbefindens, erlebten Sinns und Lebensqualität hindeuten. Diskutiert werden zudem Grenzen der bisherigen Forschung, insbesondere die Konzentration auf bestimmte Populationen und Versorgungssysteme, der Umgang mit Studienabbrüchen in einer schwer erkrankten Zielgruppe sowie Fragen der kulturellen Übertragbarkeit. Schließlich wird MCP mit anderen existenziell orientierten Interventionen der Palliativversorgung wie der Dignity Therapy verglichen. Der Beitrag schließt mit Überlegungen zur Implementierung im deutschsprachigen Raum und zu Qualifikationsanforderungen an Behandelnde.

Schlüsselwörter: Meaning-Centered Psychotherapy · Palliativversorgung · Psychoonkologie · Existenzielle Belastung · Logotherapie

ABSTRACT

In addition to physical symptoms, people with advanced, incurable illnesses frequently face existential distress, such as hopelessness, loss of meaning, or a desire for hastened death. Meaning-centered psychotherapy (MCP), developed by William Breitbart and colleagues, is a manualized intervention that explicitly builds on Viktor E. Frankl's logotherapy and aims to help patients experience meaning even in the face of limited life expectancy. This narrative review first describes the theoretical foundations and the structure of the intervention in its group and individual formats. It then summarizes the evidence from randomized controlled trials, which overall points to favorable effects on spiritual well-being, sense of meaning, and quality of life. Limitations of the existing research are discussed, in particular the concentration on specific populations and health care systems, the handling of attrition in a severely ill population, and questions of cultural transferability. Finally, MCP is compared with other existentially oriented interventions in palliative care, such as dignity therapy. The paper concludes with considerations regarding implementation in German-speaking countries and the qualifications required of clinicians.

Keywords: meaning-centered psychotherapy · palliative care · psycho-oncology · existential distress · logotherapy

1 Einleitung

Die moderne Palliativversorgung versteht sich als umfassende Begleitung schwer kranker Menschen, die körperliche, psychische, soziale und spirituelle Dimensionen des Leidens gleichermaßen berücksichtigt. Gerade die existenziellen Belastungen am Lebensende – das Erleben von Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder der Wunsch nach einem beschleunigten Tod – stellen Behandelnde vor besondere Herausforderungen, weil sie sich nicht durch symptomorientierte Maßnahmen allein beantworten lassen. Yalom (1980) hat die

Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit als eine zentrale existenzielle Grundgegebenheit beschrieben, die in der Konfrontation mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung unausweichlich wird.

Vor diesem Hintergrund wurde am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York die Meaning-Centered Psychotherapy (MCP) entwickelt. Sie gehört zu den wenigen sinnzentrierten Interventionen, die in mehreren randomisiert-kontrollierten Studien untersucht wurden, und stellt damit einen wichtigen Bezugspunkt für die Diskussion über die Evidenzbasis logotherapeutisch inspirierter Verfahren dar. Der vorliegende Beitrag gibt einen narrativen Überblick über Konzeption und Forschungsstand und fragt nach der Übertragbarkeit auf andere Versorgungskontexte.

Konzeptuell lässt sich existenzielle Belastung von Depressivität unterscheiden, auch wenn sich beide überschneiden können. Hoffnungslosigkeit, Sinnverlust oder das Gefühl, anderen zur Last zu fallen, können bei schwer kranken Menschen auch ohne das Vollbild einer depressiven Störung auftreten. Daraus ergibt sich der Bedarf an Interventionen, die existenzielle Themen ausdrücklich zum Gegenstand machen.

2 Theoretische Grundlagen

MCP knüpft ausdrücklich an das Werk Viktor E. Frankls an. Zentrale Annahmen sind, dass das Streben nach Sinn eine grundlegende menschliche Motivation darstellt, dass Sinn auch unter Bedingungen schweren Leidens und begrenzter Lebenszeit erlebt werden kann und dass Menschen die Freiheit behalten, ihre Haltung gegenüber unabänderlichen Umständen zu wählen (Frankl, 1946/2006). Breitbart und Poppito (2014) übertragen Frankls Wertkategorien in konkrete Sinnquellen, die im Verlauf der Intervention systematisch erschlossen werden: historische Sinnquellen im Sinne des eigenen Lebensvermächtnisses, einstellungsbezogene Sinnquellen im Umgang mit den Grenzen des Lebens, schöpferische Sinnquellen im Sinne von Verantwortung und Engagement sowie erlebnisbezogene Sinnquellen in Liebe, Schönheit und Humor.

Ergänzend lässt sich MCP im Rahmen des Meaning-Making-Modells von Park (2010) verstehen. Eine lebensbegrenzende Diagnose kann eine tiefe Diskrepanz zwischen globalen Lebenszielen und der aktuellen Situation erzeugen. MCP kann als strukturierte Unterstützung von Prozessen der Bedeutungsbildung verstanden werden, die diese Diskrepanz nicht leugnen, sondern in einen umfassenderen Sinnzusammenhang einbetten.

Ein weiterer Grundgedanke ist die Unterscheidung zwischen dem, was sich angesichts der Erkrankung nicht ändern lässt, und dem, was weiterhin gestaltbar bleibt. Die Intervention lädt dazu ein, beides wahrzunehmen: die Grenzen anzuerkennen, ohne die verbleibenden Möglichkeiten aus dem Blick zu verlieren. Darin spiegelt sich Frankls Gedanke, dass sich Sinn nicht nur im Tun und Erleben, sondern auch in der Haltung gegenüber dem Unabänderlichen verwirklichen kann.

3 Aufbau der Intervention

Die Gruppenform, Meaning-Centered Group Psychotherapy (MCGP), umfasst acht wöchentliche Sitzungen, die jeweils einem thematischen Schwerpunkt gewidmet sind (Breitbart & Poppito, 2014). Die Sitzungen verbinden didaktische Elemente, in denen Konzepte der Logotherapie vermittelt werden, mit erfahrungsbezogenen Übungen und Gruppendiskussion. Am Beginn steht die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Sinns und mit der Frage, wie die Erkrankung das Sinnerleben verändert hat. Es folgen Sitzungen zu den verschiedenen Sinnquellen, wobei insbesondere die Arbeit am eigenen Vermächtnis eine wichtige Rolle spielt. Den Abschluss bilden die Reflexion des gemeinsamen Prozesses und der Blick auf Hoffnungen für die verbleibende Zeit.

Für Patientinnen und Patienten, denen die Teilnahme an einer Gruppe nicht möglich ist, wurde eine Einzelform, die Individual Meaning-Centered Psychotherapy, entwickelt, die eine kürzere Sitzungsfolge vorsieht und flexibler an den Krankheitsverlauf angepasst werden kann (Breitbart et al., 2012). Die Manualisierung erleichtert die Schulung von Behandelnden und die Durchführung kontrollierter Studien, verlangt aber zugleich ein hohes Maß an klinischer Urteilskraft, um die Struktur an die individuellen Bedürfnisse schwer erkrankter Menschen anzupassen.

Ein charakteristisches Element der Intervention ist die Arbeit an einem Vermächtnisprojekt. Die Teilnehmenden werden eingeladen, ein Vorhaben zu entwickeln, das ihr Leben und ihre Werte zum Ausdruck bringt und über die eigene Lebenszeit hinausweist – etwa die Aufzeichnung von Erinnerungen, die Versöhnung mit einer nahestehenden Person oder ein kreatives Projekt. Dieses Element verbindet die von Frankl beschriebenen schöpferischen Werte mit der Frage

nach dem, was von einem Leben bleibt (Breitbart & Poppito, 2014).

4 Evidenzlage

Die erste randomisierte Pilotstudie verglich MCGP mit einer unterstützenden Gruppenpsychotherapie bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung (Breitbart et al., 2010). Die Ergebnisse wiesen auf Vorteile der sinnzentrierten Bedingung hinsichtlich spirituellen Wohlbefindens und erlebten Sinns hin; zudem ergaben sich Hinweise auf eine Abnahme von Hoffnungslosigkeit und Todeswünschen. Eine Pilotstudie zur Einzelform zeigte ebenfalls günstige Ergebnisse im Vergleich zu einer Kontrollbedingung (Breitbart et al., 2012).

Eine größere randomisierte Studie mit einer aktiven, unterstützenden Gruppenpsychotherapie als Vergleichsbedingung bestätigte im Wesentlichen diese Befundrichtung (Breitbart et al., 2015). Die sinnzentrierte Gruppe zeigte Vorteile hinsichtlich spirituellen Wohlbefindens und Lebensqualität sowie Hinweise auf eine Verringerung von Depressivität, Hoffnungslosigkeit und dem Wunsch nach einem beschleunigten Tod. Bemerkenswert ist, dass sich die Unterschiede gegenüber einer aktiven Kontrollbedingung zeigten, die selbst unspezifische Wirkfaktoren wie Gruppenkohäsion und emotionale Unterstützung enthielt. In die Meta-Analyse existenzieller Therapien von Vos et al. (2015) gingen sinnzentrierte Interventionen dieser Art ebenfalls ein und trugen zu dem insgesamt günstigen Bild strukturierter Sinninterventionen bei.

Zugleich sind die Grenzen dieser Befunde zu beachten. Die Studien wurden überwiegend an einem spezialisierten onkologischen Zentrum in den Vereinigten Staaten durchgeführt. In einer schwer erkrankten Population sind Studienabbrüche aufgrund von Krankheitsprogression oder Tod unvermeidbar, was die Interpretation von Verlaufsdaten erschwert. Schließlich ist offen, inwieweit sich die Ergebnisse auf andere Diagnosegruppen, Versorgungssysteme und kulturelle Kontexte übertragen lassen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Wahl der Zielgrößen. Die Studien verwendeten neben Symptommaßen insbesondere Instrumente zum spirituellen Wohlbefinden und zur Lebensqualität. Diese Wahl entspricht dem Anspruch der Intervention, ist aber bei Vergleichen mit anderen psychotherapeutischen Verfahren zu berücksichtigen, die primär auf Symptomreduktion zielen. Auch die Frage, welche Komponenten der Intervention für die beobachteten Veränderungen verantwortlich sind, ist bislang nicht abschließend geklärt.

5 Abgrenzung zu verwandten Interventionen

Unter den existenziell orientierten Interventionen der Palliativversorgung ist neben MCP insbesondere die Dignity Therapy bekannt geworden (Chochinov et al., 2005). Sie zielt auf die Stärkung des Würdeerlebens am Lebensende und arbeitet mit einem strukturierten Interview, aus dem ein schriftliches Dokument entsteht, das an Angehörige weitergegeben werden kann. Beide Ansätze teilen die Betonung von Vermächtnis und Lebensrückblick. MCP ist jedoch stärker psychoedukativ angelegt, umfasst mehrere Sitzungen und verfolgt das Ziel, das Sinnerleben auch im Hinblick auf die verbleibende Lebenszeit zu stärken, während die Dignity Therapy eher kompakt und auf die Erstellung eines Würdedokuments ausgerichtet ist.

Gemeinsam ist beiden Interventionen, dass sie existenzielle Themen nicht als bloße Begleiterscheinung psychischer Störungen, sondern als eigenständigen Gegenstand palliativer Versorgung begreifen. Darin unterscheiden sie sich von einem rein psychopathologischen Zugang, der existenzielle Belastung vorwiegend unter dem Gesichtspunkt komorbider Depression oder Angst betrachtet. Für die Praxis kann die Wahl zwischen den Ansätzen von der verbleibenden Lebenszeit, der körperlichen Belastbarkeit und den Präferenzen der Patientinnen und Patienten abhängen.

6 Implikationen für die Versorgung im deutschsprachigen Raum

Für die Implementierung im deutschsprachigen Raum ergeben sich mehrere Fragen. Erstens ist eine sorgfältige sprachliche und kulturelle Adaptation erforderlich, die religiöse und weltanschauliche Vielfalt berücksichtigt und nicht implizit eine bestimmte Sinnkonzeption voraussetzt. Zweitens stellt die Durchführung hohe Anforderungen an die Behandelnden: Neben psychotherapeutischer Kompetenz sind Vertrautheit mit existenziellen Fragestellungen, Erfahrung in der Begleitung Sterbender und die Fähigkeit zur Selbstreflexion im Umgang mit der eigenen Endlichkeit unerlässlich. Drittens sollte die Einführung von einer Evaluation begleitet werden, die nicht nur Symptomveränderungen, sondern auch Sinnerleben, spirituelles Wohlbefinden und die Akzeptanz der Intervention durch Patientinnen, Patienten und Angehörige erfasst.

Insgesamt kann MCP als Beispiel dafür gelten, wie logotherapeutische Grundgedanken in eine präzise beschriebene, überprüfbare Intervention übersetzt werden können. Die vorliegenden Befunde sind ermutigend, rechtfertigen jedoch keine Generalisierung über die untersuchten Kontexte hinaus. Weitere unabhängige Replikationen in unterschiedlichen Versorgungssystemen sind wünschenswert.

Auch Angehörige und Hinterbliebene kommen als Zielgruppe sinnzentrierter Interventionen in Betracht. Die Übertragung auf diese Gruppen ist konzeptuell naheliegend, da auch sie mit Verlust, Abschied und Fragen nach dem Sinn des Geschehenen konfrontiert sind; die Evidenzlage hierzu ist jedoch noch begrenzt und bedarf weiterer Forschung.

Literatur

Breitbart, W., Poppito, S., Rosenfeld, B., Vickers, A. J., Li, Y., Abbey, J., Olden, M., Pessin, H., Lichtenthal, W., Sjoberg, D., & Cassileth, B. R. (2012). Pilot randomized controlled trial of individual meaning-centered psychotherapy for patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 30(12), 1304–1309.

Breitbart, W., & Poppito, S. R. (2014). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A treatment manual. Oxford University Press.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 19(1), 21–28.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Chochinov, H. M., Hack, T., Hassard, T., Kristjanson, L. J., McClement, S., & Harlos, M. (2005). Dignity therapy: A novel psychotherapeutic intervention for patients near the end of life. Journal of Clinical Oncology, 23(24), 5520–5525.

Frankl, V. E. (2006). Man's search for meaning. Beacon Press. (Original work published 1946)

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Meaning-Centered Psychotherapy in Palliative Care: Conception, State of the Evidence, and Questions of Transferability. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 23–26.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026
S. 27–30 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

PRAXIS UND LEHRE

Logotherapeutisch orientierte Beratung bei Burnout und Sinnkrisen

Grundzüge, Vorgehen und Grenzen – mit einer konstruierten Lehrvignette

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer und Samuel R. Ashford
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Burnout wird in der Fachliteratur als Syndrom aus emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation bzw. Zynismus und reduziertem Leistungserleben beschrieben und in der ICD-11 als berufsbezogenes Phänomen, nicht als medizinische Erkrankung, klassifiziert. Neben arbeitsorganisatorischen Bedingungen wurde früh auf eine existenzielle Dimension hingewiesen: Burnout kann als Folge enttäuschter Sinnerwartungen an die eigene Arbeit verstanden werden. Der vorliegende Beitrag aus Praxis und Lehre entwickelt Grundzüge einer logotherapeutisch orientierten Beratung bei Burnout und Sinnkrisen. Nach einer begrifflichen Einordnung werden zentrale logotherapeutische Konzepte für die Beratung erschlossen, darunter das existenzielle Vakuum, die Unterscheidung zwischen Sinn und Erfolg, die drei Wertkategorien sowie die Dereflexion. Das methodische Vorgehen wird in vier Phasen dargestellt: Klärung und Abgrenzung, Entlastung und Stabilisierung, Sinn- und Werteexploration im sokratischen Dialog sowie Umsetzung und Transfer. Zur Veranschaulichung dient eine ausdrücklich konstruierte Lehrvignette, die keinen realen Beratungsfall wiedergibt. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Abgrenzung von Beratung und Psychotherapie, insbesondere der Notwendigkeit, depressive Störungen und andere behandlungsbedürftige Zustände zu erkennen und gegebenenfalls weiterzuverweisen, sowie der Gefahr, strukturelle Belastungen zu individualisieren.

Schlüsselwörter: Burnout · Sinnkrise · Logotherapeutische Beratung · Sokratischer Dialog · Beratungspsychologie

ABSTRACT

In the literature, burnout is described as a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization or cynicism, and reduced personal accomplishment, and it is classified in ICD-11 as an occupational phenomenon rather than a medical condition. Beyond organizational working conditions, an existential dimension was pointed out early on: burnout can be understood as a consequence of disappointed expectations of meaning in one's work. This contribution on practice and teaching outlines principles of logotherapeutically informed counseling for burnout and crises of meaning. Following a conceptual clarification, central logotherapeutic concepts are made accessible for counseling, including the existential vacuum, the distinction between meaning and success, the three categories of values, and dereflection. The methodological approach is presented in four phases: clarification and differential assessment, relief and stabilization, exploration of meaning and values in Socratic dialogue, and implementation and transfer. An explicitly constructed teaching vignette, which does not represent any real counseling case, serves as an illustration. Particular attention is paid to the boundary between counseling and psychotherapy, especially the need to recognize depressive disorders and other conditions requiring treatment and to refer clients where appropriate, as well as to the risk of individualizing structural stressors.

Keywords: burnout · crisis of meaning · logotherapeutic counseling · Socratic dialogue · counseling psychology

1 Einleitung und begriffliche Einordnung

Der Begriff Burnout hat seit den 1970er-Jahren eine erhebliche Verbreitung in Fachdiskussion und Öffentlichkeit erfahren. Maslach und Jackson (1981) haben mit dem Maslach Burnout Inventory ein Messinstrument vorgelegt, das Burnout über die Dimensionen emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und reduziertes Leistungserleben erfasst. In einer späteren Übersicht betonten Maslach et al. (2001) die Bedeutung des Passungsverhältnisses zwischen Person und Arbeitsumgebung, etwa hinsichtlich Arbeitsbelastung, Kontrolle, Anerkennung, Gemeinschaft, Fairness und Werten. Die Weltgesundheitsorganisation führt Burnout in der

ICD-11 als berufsbezogenes Phänomen im Kapitel der Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und ausdrücklich nicht als medizinische Erkrankung (World Health Organization, 2019).

Die Abgrenzung von Burnout gegenüber depressiven Störungen ist in der Forschung umstritten und für die Praxis von großer Bedeutung (Schaufeli & Enzmann, 1998). Der vorliegende Beitrag versteht Beratung daher ausdrücklich nicht als Behandlung psychischer Störungen. Er richtet sich an Fachpersonen in Beratungskontexten und beschreibt, wie logotherapeutische Konzepte bei berufsbezogener Erschöpfung und Sinnkrisen genutzt werden können – im Bewusstsein der Grenzen dieses Rahmens.

2 Die existenzielle Dimension des Burnouts

Pines (1993) hat Burnout aus einer existenziellen Perspektive gedeutet: Menschen, die in ihrer Arbeit eine wesentliche Quelle von Sinn suchen, seien besonders gefährdet, wenn sie erleben, dass ihr Einsatz nicht die erhoffte Bedeutung entfaltet. Burnout erscheint in dieser Sicht weniger als Folge bloßer Überlastung denn als Folge enttäuschter Sinnerwartungen. Diese Deutung ist mit Frankls Konzept des existenziellen Vakuums verwandt, das ein Gefühl innerer Leere und Sinnlosigkeit beschreibt (Frankl, 1969).

Logotherapeutisch bedeutsam ist zudem Frankls Unterscheidung zwischen Sinn und Erfolg. Wer den Wert der eigenen Arbeit ausschließlich an messbaren Ergebnissen, Anerkennung oder Effizienz misst, macht sein Sinnerleben von Bedingungen abhängig, die häufig außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Die Existenzanalyse hat dies weiter differenziert und auf die Bedeutung innerer Zustimmung zum eigenen Tun hingewiesen (Längle, 2013). Ein Tun, das zwar erfolgreich, aber ohne innere Zustimmung vollzogen wird, kann nach diesem Verständnis auf Dauer erschöpfen.

Gleichwohl ist Vorsicht geboten: Eine existenzielle Deutung darf nicht dazu führen, strukturelle Ursachen wie Arbeitsverdichtung, mangelnde Ressourcen oder ungerechte Organisationsbedingungen zu individualisieren. Sinnzentrierte Beratung ersetzt keine Veränderung belastender Arbeitsbedingungen, sondern kann allenfalls die Person darin unterstützen, ihren Handlungsspielraum zu erkennen und zu nutzen.

3 Logotherapeutische Konzepte für die Beratung

Für die Beratung bei Burnout und Sinnkrisen sind mehrere logotherapeutische Konzepte besonders hilfreich. Frankls drei Wertkategorien (Frankl, 1946) eröffnen einen differenzierten Blick auf Sinnquellen: Schöpferische Werte verwirklichen sich in der Arbeit selbst, sind aber nicht auf sie beschränkt; Erlebniswerte in Beziehungen, Natur oder Kultur können eine Gegenbewegung zu einer einseitig auf Leistung ausgerichteten Lebensführung bilden; Einstellungswerte betreffen die Haltung gegenüber Belastungen, die sich nicht unmittelbar ändern lassen. Schnell (2020) hat zudem darauf hingewiesen, dass eine größere Vielfalt an Sinnquellen mit einem stabileren Sinnerleben einhergehen kann.

Ein weiteres Konzept ist die Dereflexion. Sie zielt darauf, eine übermäßige, sorgenvolle Selbstbeobachtung zu lösen, indem die Aufmerksamkeit auf sinnvolle Aufgaben und Beziehungen jenseits der eigenen Befindlichkeit gelenkt wird. Lukas (1998) hat die methodische Anwendung der Dereflexion und anderer logotherapeutischer Verfahren für Beratung und Therapie ausführlich beschrieben. Bei Erschöpfung ist Dereflexion allerdings behutsam einzusetzen: Sie darf nicht als Aufforderung missverstanden werden, Warnsignale des Körpers zu übergehen.

Hilfreich ist außerdem die Frage, ob Sinn ausschließlich aus der Arbeit bezogen wird oder ob weitere Lebensbereiche zum Sinnerleben beitragen. Menschen mit sehr hoher beruflicher Identifikation beziehen oft einen Großteil ihres Sinnerlebens aus der Arbeit. Gerät diese Quelle in die Krise, fehlt es an Alternativen. Beratung kann dazu beitragen, das Spektrum möglicher Sinnquellen wieder zu erweitern, ohne die Bedeutung der Arbeit abzuwerten.

4 Methodisches Vorgehen in vier Phasen

Die erste Phase dient der Klärung und Abgrenzung. Hier werden Anliegen, Belastungsfaktoren und Ressourcen erhoben. Zugleich ist sorgfältig zu prüfen, ob Hinweise auf eine depressive Störung, eine Suchtproblematik, Suizidalität oder körperliche Erkrankungen vorliegen, die eine ärztliche oder psychotherapeutische Abklärung erfordern. Beratung kann in diesen Fällen eine Behandlung nicht ersetzen und sollte auf eine angemessene Weiterverweisung hinwirken.

Die zweite Phase zielt auf Entlastung und Stabilisierung. Erholung, Schlaf, soziale Unterstützung und gegebenenfalls Gespräche mit Vorgesetzten oder betrieblichen Ansprechpersonen stehen im Vordergrund. Sinnfragen werden in dieser Phase eher aufgenommen als vertieft, da eine akut erschöpfte

Person häufig nicht über die Kraft für eine grundlegende Neuorientierung verfügt.

In der dritten Phase erfolgt die Sinn- und Werteexploration, vorzugsweise im sokratischen Dialog. Logotherapeutisch verstanden zielt dieser nicht darauf, der ratsuchenden Person Sinn zuzuschreiben, sondern ihr durch Fragen zu ermöglichen, eigene Werterfahrungen und Möglichkeiten zu entdecken. Hier bestehen Berührungspunkte zur geleiteten Entdeckung in der kognitiven Verhaltenstherapie, die ebenfalls mit systematischem Fragen arbeitet (Kazantzis et al., 2014; Overholser, 1993). Der Unterschied liegt im Gegenstand: Während der sokratische Dialog in der kognitiven Verhaltenstherapie vor allem der Prüfung von Überzeugungen dient, richtet er sich in der Logotherapie auf Werte, Verantwortung und Sinnmöglichkeiten.

Die vierte Phase dient der Umsetzung und dem Transfer. Gemeinsam werden konkrete Schritte entwickelt, die das Erkannte in den Alltag übertragen: eine veränderte Gewichtung von Lebensbereichen, die Klärung beruflicher Rollen, die Pflege vernachlässigter Erlebniswerte oder auch die Entscheidung für eine berufliche Neuorientierung.

Wichtig ist dabei, dass die Schritte realistisch bleiben und die Erschöpfung nicht durch neue Leistungsansprüche verstärken. Eine logotherapeutisch orientierte Beratung fragt nicht nur, was eine Person tun soll, sondern auch, was sie lassen darf und welche Haltung sie gegenüber dem einnehmen möchte, was sich vorerst nicht ändern lässt.

5 Konstruierte Lehrvignette

Hinweis: Die folgende Vignette ist eine für Lehrzwecke konstruierte Darstellung. Sie gibt keinen realen Beratungsfall wieder; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen sind nicht beabsichtigt.

Eine erfahrene Pflegefachkraft auf einer internistischen Station sucht eine Beratungsstelle auf, weil sie sich seit Monaten erschöpft, gereizt und innerlich leer fühlt. Sie berichtet, dass sie ihren Beruf früher als Berufung erlebt habe, inzwischen aber den Eindruck habe, „nur noch zu funktionieren“. In der ersten Phase klärt die Beraterin, ob Hinweise auf eine depressive Störung vorliegen, und empfiehlt eine hausärztliche Abklärung, die die Ratsuchende auch wahrnimmt. In der Stabilisierungsphase werden Entlastungsmöglichkeiten besprochen, darunter ein Gespräch mit der Stationsleitung über die Dienstplanung.

In der Explorationsphase fragt die Beraterin im sokratischen Stil, in welchen Momenten der Arbeit die Ratsuchende zuletzt den Eindruck hatte, dass ihr Tun wichtig war. Die Ratsuchende erinnert sich an ein Gespräch mit einem schwer kranken Patienten, für das sie sich trotz Zeitdruck einige Minuten genommen hatte. Im weiteren Dialog wird deutlich, dass für sie weniger die Menge erledigter Aufgaben als die Qualität der Begegnung bedeutsam ist und dass gerade diese unter den gegenwärtigen Bedingungen zu kurz kommt. In der Transferphase entwickelt sie konkrete Schritte, um solche Begegnungen bewusster zu gestalten, und beschließt zugleich, die strukturellen Belastungen im Team anzusprechen.

Für die Lehre verdeutlicht die Vignette drei Punkte: die Notwendigkeit sorgfältiger Abklärung zu Beginn, die Verbindung individueller Sinnexploration mit der Benennung struktureller Belastungen sowie die Funktion des sokratischen Dialogs als Methode des Entdeckens statt des Belehrens.

6 Grenzen und Schlussfolgerungen

Logotherapeutisch orientierte Beratung kann Menschen mit berufsbezogener Erschöpfung und Sinnkrisen einen differenzierten Rahmen bieten, um ihre Situation zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Ihre Wirksamkeit im Kontext von Burnout ist jedoch bislang nicht in kontrollierten Studien belegt; die hier dargestellten Grundzüge sind daher als theoretisch begründete und praxisbezogene Orientierung, nicht als evidenzbasiertes Behandlungsprogramm zu verstehen. Für die Weiterbildung ergibt sich die Aufgabe, neben der Vermittlung logotherapeutischer Konzepte insbesondere die Kompetenzen zur Abgrenzung von behandlungsbedürftigen Zuständen und zur Reflexion organisationaler Rahmenbedingungen zu stärken.

Für die Lehre eignet sich das beschriebene Vorgehen insbesondere zur Einübung einer fragenden, nicht belehrenden Gesprächsführung. In Rollenspielen können Studierende erproben, wie sich Fragen nach Werterfahrungen formulieren lassen, ohne Antworten nahezulegen, und wie sich Hinweise auf behandlungsbedürftige Zustände im Gespräch erkennen lassen. Supervision und Selbstreflexion sind dabei unverzichtbar, weil die Arbeit an Sinnfragen eigene Wertvorstellungen der Beratenden berührt und die Gefahr besteht, diese unbemerkt zu übertragen.

Literatur

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Kazantzis, N., Fairburn, C. G., Padesky, C. A., Reinecke, M., & Teesson, M. (2014). Unresolved issues regarding the research and practice of cognitive behavior therapy: The case of guided discovery using Socratic questioning. Behaviour Change, 31(1), 1–17.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Lukas, E. (1998). Lehrbuch der Logotherapie: Menschenbild und Methoden. Profil.

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2(2), 99–113.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422.

Overholser, J. C. (1993). Elements of the Socratic method: I. Systematic questioning. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 30(1), 67–74.

Pines, A. M. (1993). Burnout: An existential perspective. In W. B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (pp. 33–51). Taylor & Francis.

Schaufeli, W. B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. Taylor & Francis.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

World Health Organization. (2019). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th rev.). World Health Organization.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Whitcombe, E. M., Pazer, S., & Ashford, S. R. (2026). Logotherapeutically Oriented Counseling for Burnout and Crises of Meaning: Main Features, Procedure, and Limitations – With a Constructed Teaching Vignette. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 27–30.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026
S. 31–33 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

REZENSION

Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager

Viktor E. Frankls „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ bzw. „Man’s Search for Meaning“ – eine Relektüre aus heutiger Sicht

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe und Sora Pazer
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Viktor E. Frankls Bericht über seine Erfahrungen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern erschien 1946 in Wien unter dem Titel „Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“ und wurde später unter dem Titel „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ bekannt. In der englischsprachigen Fassung „Man’s Search for Meaning“, die um eine Einführung in die Logotherapie erweitert wurde, zählt das Buch zu den meistgelesenen psychologischen Werken des 20. Jahrhunderts. Die vorliegende Rezension unternimmt eine Relektüre aus der Perspektive der gegenwärtigen Psychologie. Sie beschreibt zunächst Aufbau und Inhalt des Buches, insbesondere Frankls Darstellung der psychischen Reaktionen der Häftlinge in drei Phasen sowie seine Reflexionen über innere Freiheit und Sinn im äußersten Leid. Anschließend wird die besondere Textgattung zwischen Zeugnis, phänomenologischer Beschreibung und programmatischer Grundlegung der Logotherapie gewürdigt. Kritisch diskutiert werden die Grenzen einer Verallgemeinerung individueller Erfahrung, die Gefahr einer nachträglichen Sinnzuschreibung an das Überleben sowie das Verhältnis des Buches zu anderen Zeugnissen Überlebender. Die Rezension kommt zu dem Ergebnis, dass das Werk seine Bedeutung als existenzielles Dokument und als Ausgangspunkt sinnzentrierter Psychologie behält, aber nicht als empirischer Beleg für die Wirksamkeit von Sinnorientierung gelesen werden sollte.

Schlüsselwörter: Viktor E. Frankl · Rezension · Konzentrationslager · Logotherapie · Innere Freiheit

ABSTRACT

Viktor E. Frankl's account of his experiences in National Socialist concentration camps was first published in Vienna in 1946 under the title “Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager” and later became known as “… trotzdem Ja zum Leben sagen.” In its English version, “Man's Search for Meaning,” which was expanded by an introduction to logotherapy, the book is among the most widely read psychological works of the twentieth century. This review undertakes a rereading from the perspective of contemporary psychology. It first describes the structure and content of the book, in particular Frankl's account of the prisoners' psychological reactions in three phases and his reflections on inner freedom and meaning in extreme suffering. It then appraises the book's particular genre, situated between testimony, phenomenological description, and programmatic foundation of logotherapy. Critical points include the limits of generalizing from individual experience, the risk of retrospectively attributing meaning to survival, and the relationship of the book to other survivor testimonies. The review concludes that the work retains its significance as an existential document and as a point of departure for meaning-centered psychology, but should not be read as empirical evidence for the effectiveness of meaning orientation.

Keywords: Viktor E. Frankl · book review · concentration camps · logotherapy · inner freedom

1 Zum besprochenen Werk

Besprochen werden: Frankl, V. E. (1946). Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Verlag für Jugend und Volk; sowie die englischsprachige Ausgabe Frankl, V. E. (2006). Man’s search for meaning. Beacon Press. Die deutschsprachige Fassung ist seit den späten 1940er-Jahren unter dem Titel „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ in zahlreichen Auflagen erschienen.

Kaum ein psychologisches Buch des 20. Jahrhunderts hat eine vergleichbare Leserschaft gefunden. Frankl schrieb den Bericht nach eigener Darstellung innerhalb weniger Tage nach seiner Rückkehr nach Wien, und ursprünglich sollte er anonym erscheinen. Dass eine Fachzeitschrift dieses Buch rund acht Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung bespricht, bedarf einer

Begründung: Es ist nicht nur ein historisches Dokument, sondern bis heute der für viele Menschen erste Zugang zur Logotherapie und damit ein Text, dessen Lesarten das Verständnis sinnzentrierter Psychologie prägen.

Die Rezension folgt der deutschsprachigen Originalfassung und zieht die englischsprachige Ausgabe heran, soweit diese zusätzliche Teile enthält. Inhalte werden sinngemäß wiedergegeben; auf ausführliche wörtliche Auszüge wird verzichtet.

2 Aufbau und Inhalt

Der Kern des Buches ist Frankls Bericht über seine Erfahrungen als Häftling. Frankl wurde 1942 mit seiner Familie in das Ghetto Theresienstadt deportiert und später nach Auschwitz sowie in Außenlager des Konzentrationslagers Dachau gebracht; seine Eltern, sein Bruder und seine erste Frau kamen ums Leben (Klingberg, 2001; Längle, 1998). Frankl verzichtet weitgehend auf eine chronologische Erzählung und versucht stattdessen, typische psychische Reaktionen der Häftlinge zu beschreiben. Er unterscheidet drei Phasen: den Schock der Aufnahme, die Phase des eigentlichen Lagerlebens, die durch Apathie, emotionale Abstumpfung und die Reduktion auf das unmittelbare Überleben gekennzeichnet ist, sowie die Phase nach der Befreiung mit ihren eigenen Schwierigkeiten, darunter Gefühle der Entfremdung und Verbitterung (Frankl, 1946/2006).

Durch die Beschreibung ziehen sich Reflexionen, die später zu Grundgedanken der Logotherapie werden. Frankl betont, dass dem Menschen selbst unter extremen Bedingungen eine letzte Freiheit bleibe: die Freiheit, eine Haltung zu den Umständen einzunehmen. Er berichtet von Augenblicken innerer Zuwendung zu geliebten Menschen, von der Bedeutung einer Aufgabe, die auf einen wartet, und von Mitgefangenen, die anderen ihr letztes Stück Brot gaben. Zugleich beschreibt er, wie der Verlust jeglicher Zukunftsperspektive den inneren Halt untergraben konnte.

Die englischsprachige Ausgabe ergänzt den Bericht um eine knappe Einführung in die Grundbegriffe der Logotherapie sowie um ein späteres Nachwort, in dem Frankl seine Position eines „tragischen Optimismus“ darlegt: die Überzeugung, dass Menschen auch angesichts von Leid, Schuld und Tod Sinn finden können (Frankl, 1946/2006).

Stilistisch bemerkenswert ist die Zurückhaltung, mit der Frankl von sich selbst spricht. Er beschreibt eigene Erlebnisse meist nur, soweit sie typische Erfahrungen veranschaulichen, und verzichtet auf eine ausführliche Darstellung des eigenen Leidens. Diese Zurückhaltung verleiht dem Text eine eigentümliche Sachlichkeit, die von vielen Leserinnen und Lesern als besonders eindringlich empfunden wird.

Der logotherapeutische Teil der englischsprachigen Ausgabe ist knapp gehalten. Er führt in Begriffe wie den Willen zum Sinn, das existenzielle Vakuum, die noogene Neurose und die paradoxe Intention ein. Wer die Logotherapie systematisch kennenlernen möchte, ist auf Frankls fachliche Hauptwerke verwiesen; als Einführung in das Denken Frankls erfüllt dieser Teil jedoch seinen Zweck.

3 Würdigung

Die besondere Leistung des Buches liegt in seiner Verbindung von Zeugnis und psychologischer Beobachtung. Frankl schreibt als Betroffener, aber mit dem Blick des Psychiaters, und er bemüht sich um eine Sprache, die nicht anklagt, sondern zu verstehen sucht. Die Schilderung psychischer Reaktionen auf extreme Belastung ist in ihrer Genauigkeit eindrücklich, auch wenn sie nicht den Anspruch einer systematischen Untersuchung erheben kann.

Für die Psychotherapie ist vor allem Frankls Beharren auf einer Dimension menschlicher Freiheit bedeutsam, die auch dort fortbesteht, wo äußere Freiheit vollständig fehlt. Dieser Gedanke ist für die spätere Konzeption der Einstellungswerte zentral und hat existenziell orientierte Ansätze weit über die Logotherapie hinaus beeinflusst (Yalom, 1980). Auch die gegenwärtige Sinnforschung bezieht sich häufig auf das Buch als Ausgangspunkt, obgleich sie ihre Konzepte inzwischen eigenständig entwickelt und empirisch prüft (Wong, 2012).

Hervorzuheben ist auch die Bedeutung, die Frankl der Zukunftsorientierung beimisst. Er beschreibt, wie Mithäftlinge, die eine Aufgabe oder einen Menschen vor Augen hatten, für den sie weiterleben wollten, inneren Halt fanden, und greift in diesem Zusammenhang Nietzsches Wort auf, wer ein Warum zum Leben habe, ertrage fast jedes Wie. Diese Beobachtungen nehmen Fragestellungen vorweg, die in der späteren Forschung zu Hoffnung, Zielorientierung und Bedeutungsbildung unter Belastung aufgegriffen wurden.

Didaktisch eignet sich das Buch hervorragend als Einstieg in Lehrveranstaltungen zur existenziellen Psychotherapie. Es regt zur Auseinandersetzung mit Fragen an, die in einem auf Störungen und Techniken konzentrierten Curriculum leicht zu kurz kommen: Was bleibt einem Menschen, wenn ihm äußerlich fast

alles genommen ist? Welche Rolle spielen Haltung, Beziehung und Verantwortung für die Bewältigung extremer Belastung? Solche Fragen lassen sich im Seminar produktiv mit der gegenwärtigen Sinnforschung verbinden.

Nicht zuletzt beeindruckt das Buch durch seine sprachliche Klarheit. Frankl verzichtet weitgehend auf Fachterminologie und erreicht dadurch eine Leserschaft weit über die Fachwelt hinaus. Dass ein Text, der unter den denkbar schwersten Bedingungen gereift ist, ohne Pathos auskommt und dennoch zu tiefgreifenden Fragen führt, gehört zu den Gründen für seine anhaltende Wirkung.

4 Kritische Anmerkungen

Eine Relektüre aus heutiger Sicht muss zugleich auf Grenzen hinweisen. Erstens beruht das Buch auf der Erfahrung und Erinnerung eines Einzelnen. Frankls Beschreibungen typischer Reaktionen sind Verallgemeinerungen aus persönlicher Beobachtung; sie können wertvolle Hypothesen liefern, aber keine empirisch gesicherten Aussagen über die psychischen Folgen extremer Traumatisierung begründen.

Zweitens besteht die Gefahr einer Lesart, die das Überleben auf eine innere Sinnorientierung zurückführt und damit im Umkehrschluss nahelegt, den Ermordeten habe es an Sinn oder Haltung gefehlt. Frankl selbst hat dieser Deutung widersprochen und betont, dass gerade die Besten nicht zurückgekehrt seien (Frankl, 1946/2006). Primo Levi hat in seinen späteren Reflexionen die Rolle von Zufall und äußeren Umständen für das Überleben eindringlich hervorgehoben (Levi, 1986). Eine verantwortliche Lektüre sollte diese Perspektive einbeziehen, um nicht unbeabsichtigt eine Hierarchie zwischen Überlebenden und Ermordeten zu errichten.

Drittens ist das Buch im Gespräch mit anderen Zeugnissen zu lesen. Die Berichte von Levi (1958) und die Essays von Améry (1966) setzen andere Akzente und lassen erkennen, dass die Erfahrung der Lager sich einer einheitlichen Deutung entzieht. Gerade im Kontrast zu ihnen wird sichtbar, dass Frankls Bericht nicht nur Zeugnis, sondern auch Grundlegung eines therapeutischen Programms ist – eine doppelte Funktion, die bei der Lektüre bewusst gehalten werden sollte.

Viertens ist auf die Rezeptionsgeschichte hinzuweisen. Das Buch wird häufig in Ratgeber- und Motivationskontexten zitiert, in denen einzelne Sätze aus ihrem Zusammenhang gelöst werden. Eine solche Rezeption droht die Schwere des Berichteten zu verdecken und Frankls Gedanken zu einer Formel positiven Denkens zu verkürzen. Frankl selbst hat sich gegen eine Verklärung des Leidens gewandt und betont, dass vermeidbares Leid zu beseitigen sei.

Schließlich wäre es wünschenswert, die psychischen Folgen extremer Traumatisierung, die Frankl für die Zeit nach der Befreiung andeutet, stärker mit der späteren psychotraumatologischen Forschung ins Gespräch zu bringen. Frankls Beschreibungen von Entfremdung, Verbitterung und Enttäuschung nach der Rückkehr gehören zu den weniger beachteten, aber psychologisch besonders aufschlussreichen Passagen des Buches.

5 Fazit

„… trotzdem Ja zum Leben sagen“ bleibt ein bedeutendes Dokument menschlicher Selbstbehauptung unter extremen Bedingungen und ein unverzichtbarer Ausgangspunkt für das Verständnis der Logotherapie. Für Studium und Weiterbildung ist das Buch uneingeschränkt zu empfehlen, sofern es nicht als empirischer Beleg für die Wirksamkeit von Sinnorientierung, sondern als existenzielles Zeugnis und als Quelle theoretischer Intuitionen gelesen wird. Ergänzend sollten Leserinnen und Leser biografische Darstellungen (Klingberg, 2001; Längle, 1998) sowie andere Zeugnisse Überlebender heranziehen, um die historische und menschliche Dimension des Textes angemessen zu erfassen.

Für die Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie ist diese Relektüre zugleich eine Selbstvergewisserung: Sie erinnert daran, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit Sinn aus einer existenziellen Erfahrung hervorgegangen ist, die sich jeder Instrumentalisierung entzieht. Methodische Strenge und Respekt vor dieser Herkunft schließen einander nicht aus, sondern bedingen sich gegenseitig.

Literatur

Améry, J. (1966). Jenseits von Schuld und Sühne: Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Szczesny.

Frankl, V. E. (1946). Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Verlag für Jugend und Volk.

Frankl, V. E. (2006). Man's search for meaning. Beacon Press. (Original work published 1946)

Klingberg, H., Jr. (2001). When life calls out to us: The love and lifework of Viktor and Elly Frankl. Doubleday.

Längle, A. (1998). Viktor Frankl: Ein Porträt. Piper.

Levi, P. (1958). Se questo è un uomo. Einaudi.

Levi, P. (1986). I sommersi e i salvati. Einaudi.

Wong, P. T. P. (Ed.). (2012). The human quest for meaning: Theories, research, and applications (2nd ed.). Routledge.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Whitcombe, E. M., & Pazer, S. (2026). A Psychologist Experiences the Concentration Camp: Viktor E. Frankl's *... trotzdem Ja zum Leben sagen* or *Man's Search for Meaning* – A Rereading from Today's Perspective. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 31–33.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.